Клинические рекомендации

# Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная<br>**B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная<br>**B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная<br>**B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках<br>**B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках<br>**J00** — Острый назофарингит (насморк)<br>**J01** — Острый синусит<br>**J02** — Острый фарингит<br>**J03** — Острый тонзиллит [ангина]<br>**J04** — Острый ларингит и трахеит<br>**J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит<br>**J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации<br>**J20** — Острый бронхит<br>**J21** — Острый бронхиолит<br>**J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
| Пациенты | взрослые |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года |
| Разработчик | Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ) |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Главное** ..... 3

**2. Клиника и классификация** ..... 3

2.1 Определение ..... 3

2.2 Возбудители ..... 3

2.3 Возбудители и ведущие синдромы ..... 3

2.4 Классификация ..... 4

2.5 Критерии тяжести ..... 4

2.6 Клиническая картина ..... 4

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей ..... 4

2.8 Осложнения 5
2.9 Жалобы и анамнез 5
**3. Диагностика 5**
3.1 Осмотр 5
3.2 Анализы 6
3.3 Инструментальные исследования 6
3.4 Консультации 6
3.5 Алгоритм на амбулаторном приёме 7
3.6 Дифференциальная диагностика 7
3.7 Отличия основных ОРВИ 7
**4. Лечение 8**
4.1 Базисная терапия 8
4.2 Противовирусные препараты 8
4.3 Жаропонижающие 9
4.4 Нос 9
4.5 Горло 10
4.6 Кашель 10
4.7 Антибиотики 11
4.8 Антибиотики при бактериальном риносинусите 11
4.9 Тяжёлое течение 11
4.10 Другие препараты 11
4.11 Реабилитация 12
**5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 12**
5.1 Госпитализация 12
5.2 Наблюдение после болезни 12
5.3 Профилактика 13
**6. Источник и актуальность 14**
6.1 Неточности в самом тексте КР 14

## 1. Главное

- При неосложнённой ОРВИ антибиотики не назначают в первые 10–14 дней, даже если есть ринит, конъюнктивит, затемнение пазух на рентгенограмме, ларингит, круп или бронхит.
- Если носовое дыхание затруднено дольше 3–5 дней и есть подозрение на бактериальный синусит, делают рентгенографию или КТ пазух, чтобы вовремя направить пациента к оториноларингологу. Это осложнение бывает в 0,5–2% случаев, а изменения в пазухах не всегда означают бактериальное воспаление.
- Противовирусные препараты назначают не позднее 48 часов от начала болезни: в первой линии — препараты прямого действия, во второй — иммунотропные.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите назначают местные деконгестанты: они облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- При бактериальном риносинусите препарат выбора — амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки 7–10 дней.
- Срочно госпитализируют при частоте дыхания больше 24 в минуту, сатурации ниже 95% и очаговых изменениях на рентгенограмме грудной клетки.

## 2. Клиника и классификация

### 2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа вирусных болезней, которые передаются воздушно-капельным путём и поражают преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп A и B и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) описаны в отдельных рекомендациях и здесь не рассматриваются.

### 2.2 Возбудители

Чаще всего ОРВИ вызывают респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) A и B, респираторный энтеровирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус человека, вирусы парагриппа 1–4 типов и сезонные коронавирусы. В основном это РНК-содержащие вирусы. Их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития болезни и клинические проявления.

### 2.3 Возбудители и ведущие синдромы

| Возбудитель | Основные синдромы |
|---|---|
| **Вирусы парагриппа** | Ларингит, ринофарингит, ложный круп |
| **Респираторно-синцитиальный вирус** | Бронхит, бронхиолит |
| **Аденовирусы** | Фарингит, тонзиллит, бронхит |
| **Риновирусы** | Ринит, фарингит |
| **Коронавирусы человека** | Ринофарингит, бронхит |
| **Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)** | Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром |

### 2.4 Классификация

По течению ОРВИ бывает типичной (манифестной) и атипичной (бессимптомной, стёртой). По тяжести различают лёгкую, среднюю, тяжёлую и очень тяжёлую степень. По характеру течения — неосложнённую и осложнённую: со специфическими осложнениями, с осложнениями от вторичной микрофлоры или с обострением хронических болезней. По длительности — острую (5–10 дней), подострую (11–30 дней) и затяжную (больше 30 дней).

### 2.5 Критерии тяжести

| Форма | Признаки |
|---|---|
| **Лёгкая** | Температура 37–37,5 °C или нормальная, умеренные катаральные явления, болезнь длится 4–6 дней |
| **Среднетяжёлая** | Температура 38–39 °C, выраженные катаральные явления; без осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней |
| **Тяжёлая** | Температура 39–41 °C; на фоне слабых или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения |

### 2.6 Клиническая картина

Инкубационный период — от 1 до 14 суток, у самых распространённых вирусов — 1–5 дней. Болезнь обычно начинается постепенно с умеренной интоксикации: температура поднимается до субфебрильной или фебрильной, появляются слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах. Одновременно развивается катаральный синдром — першение в горле, кашель, насморк, иногда конъюнктивит. Возможно увеличение лимфоузлов, реже — печени (при аденовирусной инфекции).

### 2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

| Синдром | Признаки |
|---|---|
| **Острый ринит** | Воспаление слизистой полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Слизь, стекающая по задней стенке глотки, вызывает кашель. |
| **Фарингит** | Воспаление слизистой и лимфоидной ткани глотки: внезапное першение и сухость в горле, боль при глотании. |
| **Тонзиллит** | Изменения нёбных миндалин — и вирусные, и как обострение бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах. |
| **Ларингит** | Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первые симптомы — сухой «лающий» кашель и осиплость. |
| **Трахеит** | Воспаление слизистой трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель. |
| **Бронхит** | Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель держится 2 недели и дольше (до месяца). На второй неделе мокрота может стать желтовато-зеленоватой из-за фибрина и присоединения бактерий. |

### 2.8 Осложнения

Осложнения бывают специфическими и вызванными вторичной микрофлорой. Специфические — менингизм, острая дыхательная недостаточность, энцефалопатия, инфекционно-токсический шок, респираторный дистресс-синдром взрослых, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, тромбоэмболия.

Вторичная бактериальная микрофлора вызывает острый синусит, острый отит, острый бронхит, обострение хронических бронхолёгочных болезней и пневмонию.

### 2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют недомогание, температуру, утомляемость и слабость, снижение аппетита, головную боль, боль в горле, затруднение носового дыхания, насморк, осиплость, сухой или влажный кашель, увеличение лимфоузлов, боль в животе, одышку, затруднённый вдох, рвоту, судороги и потерю сознания.

Выясняют, сколько длится болезнь, и есть ли причины, которые мешают сразу начать лечение или требуют его изменить из-за сопутствующих болезней.

Это непереносимость лекарств, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронической болезни, требующее участия профильного специалиста, и отказ от лечения.

Уточняют эпидемиологический анамнез: контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода, сезонный подъём заболеваемости, вспышки в организованных коллективах, а также была ли прививка от гриппа.

Выявляют факторы риска тяжёлого и осложнённого течения: хронические болезни лёгких и сердца, нарушения обмена веществ, хроническую болезнь почек, болезни печени, неврологические состояния, гемоглобинопатии, иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров), злокачественные опухоли, возраст старше 65 лет и беременность.

---

## 3. Диагностика

Диагноз ставят по жалобам, анамнезу, осмотру, лабораторным и инструментальным исследованиям. Задача — определить нозологию и клиническую форму, тяжесть, осложнения и показания к лечению.

### 3.1 Осмотр

Осмотр начинают с кожи и видимых слизистых: цвет (гиперемия, бледность, цианоз), влажность, отёчность, инъекция сосудов склер, конъюнктивит. Оценивают носовое дыхание и признаки ринита, осматривают ротоглотку: гиперемию дужек и задней стенки, миндалины, рыхлость и зернистость задней стенки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы обязательно ищут уже на первом этапе, но они бывают и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

Всем осматривают и пальпируют лимфоузлы головы и шеи, оценивая увеличение и болезненность.

Всем проводят пальпацию, перкуссию и аускультацию лёгких: оценивают частоту дыхания, дыхательные шумы, хрипы и крепитацию, которая появляется при пневмонии.

Измеряют пульс и артериальное давление, выслушивают сердце, чтобы оценить тяжесть, выявить тахикардию, шумы, осложнения и сопутствующие болезни.

### 3.2 Анализы

Всем делают общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, чтобы оценить тяжесть, вовремя заметить осложнения и исключить бактериальные осложнения.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное число лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

Всем делают общий анализ мочи, чтобы выявить нарушение функции почек, декомпенсацию сопутствующих болезней, исключить инфекцию мочевых путей и нефропатию. При неосложнённой ОРВИ изменений нет; при выраженной лихорадке возможны преходящие повышение плотности мочи, небольшие лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении делают биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, амилаза, мочевина) и исследуют электролиты.

Для своевременного назначения противовирусного лечения возбудитель определяют экспресс-методами.

Это иммунохроматографический тест на антигены вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки у пациентов, обратившихся не позднее 2 суток от начала симптомов.

Для определения возбудителя мазки из носоглотки и ротоглотки исследуют методами амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР, LAMP и другими) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Это самый эффективный метод: нуклеиновые кислоты вирусов находят в среднем до 7 дней, максимум до 2 недель от начала болезни, если сохраняются признаки поражения верхних дыхательных путей. Результат готов через 4–6 часов.

Пациентов с тонзиллитом и пневмонией обследуют по клиническим рекомендациям для этих болезней.

### 3.3 Инструментальные исследования

Для ранней диагностики дыхательной недостаточности измеряют сатурацию крови кислородом (SpO2) пульсоксиметром. Это простой и надёжный способ найти пациентов с гипоксемией, которым нужна респираторная поддержка.

При бронхите, который длится больше 3–5 дней, и при физикальных признаках поражения лёгких делают рентгенографию грудной клетки или КТ лёгких, чтобы исключить или подтвердить пневмонию.

Если носовое дыхание затруднено больше 3–5 дней и есть подозрение на синусит из-за присоединения бактериальной флоры, делают рентгенографию или КТ околоносовых пазух, чтобы вовремя направить пациента к оториноларингологу.

Такое осложнение бывает в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в пазухах не всегда означают их бактериальное поражение.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно у пожилых, регистрируют ЭКГ, чтобы оценить работу сердца и выявить нарушения ритма на фоне интоксикации.

### 3.4 Консультации

При подозрении на осложнения пациента консультируют смежные специалисты: оториноларинголог — при синусите и отите, невролог — при энцефалопатии, пульмонолог — при признаках пневмонии, гематолог — при выраженных изменениях крови и геморрагическом синдроме, кардиолог — при миокардите и острой сердечно-сосудистой недостаточности, акушер-гинеколог — при беременности.

При быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания больше 25 в минуту, SpO2 ниже 92%) или другой органной недостаточности (2 балла и больше по шкале SOFA) пациента консультирует анестезиолог-реаниматолог для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

### 3.5 Алгоритм на амбулаторном приёме

Если при осмотре есть катаральные явления, делают общий анализ крови и обследуют лёгкие. Без изменений в лёгких лечат амбулаторно; если на фоне лечения сохраняется лихорадка, повторяют анализ крови и при изменениях направляют к инфекционисту. При изменениях в лёгких делают рентгенографию; если признаков пневмонии нет, делают рентгенографию пазух и при изменениях в них направляют к оториноларингологу.

### 3.6 Дифференциальная диагностика

ОРВИ отличают от острых респираторных заболеваний бактериальной природы, в том числе вирусную пневмонию от бактериальной.

### 3.7 Отличия основных ОРВИ

| Инфекция | Начало и течение | Температура и интоксикация | Нос и глотка | Кашель и другое |
|---|---|---|---|---|
| **Парагрипп** | Инкубация 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое | 37–38 °C, может долго держаться; интоксикация слабая или умеренная, 1–3 дня | Катаральные явления с первого дня, осиплость; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия зева, мягкого нёба и задней стенки глотки | Сухой лающий кашель, иногда до 12–21 дня; ведущий синдром — ларингит, ложный круп |
| **РС-инфекция** | Инкубация 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, иногда затяжное | Субфебрильная, иногда нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней | Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых | Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм |
| **Аденовирусная инфекция** | Инкубация 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное | Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней | Сильно выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки | Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; может быть полиаденит, увеличение печени и селезёнки, экзантема, диарея |

## 4. Лечение

Задачи лечения — подавить размножение вируса в ранние сроки, не дать болезни прогрессировать, добиться полного выздоровления и предупредить осложнения.

Хирургическое лечение не проводится.

### 4.1 Базисная терапия

Всем пациентам при любой тяжести назначают базисную терапию: постельный режим, диету и обильное питьё. В рацион включают легкоусвояемые продукты, богатые витаминами; алкоголь в любом виде запрещён.

Всем пациентам без поражения лёгких проводят дезинтоксикацию. При лёгкой и средней тяжести амбулаторно пациент выпивает 2–3 литра жидкости в сутки. При средней тяжести в стационаре пьют и (или) получают инфузии 800–2000 мл растворов, влияющих на водно-электролитный баланс. При осложнённом и тяжёлом течении дезинтоксикацию проводят внутривенно с коррекцией электролитов.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации назначают меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

### 4.2 Противовирусные препараты

Противовирусные препараты назначают не позднее 48 часов от начала болезни. Первая линия — препараты прямого противовирусного действия, вторая — иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Препарат выбирают в зависимости от возбудителя. Раннее назначение предупреждает тяжёлое течение и осложнения, а нужен ли противовирусный препарат конкретному пациенту, врач решает индивидуально.

| Препарат | Доза | УУР, УДД |
|---|---|---|
| **Риамиловир (первая линия)** | 250 мг 3 раза в день 5 дней; начать не позднее 2-го дня болезни | C, 1 |
| **Умифеновир (первая линия)** | 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 5 суток. Противопоказан в I триместре беременности | C, 2 |
| **Энисамия йодид (первая линия)** | 500 мг 3 раза в сутки внутрь 5–7 дней. Противопоказан при беременности и кормлении грудью, тяжёлых поражениях печени и почек, непереносимости лактозы и фруктозы | C, 2 |
| **Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)** | 90 мг 1 раз в день 5–7 дней, желательно начать в первые 2 суток. Противопоказан при беременности и лактации | C, 5 |
| **Меглюмина акридонацетат (вторая линия)** | По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток). Противопоказан при беременности и лактации | B, 1 |
| **Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)** | В первый день 200 мг 3 раза, следующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг) | C, 5 |

| Препарат | Доза | УУР, УДД |
|---|---|---|
| **Азоксимера бромид (вторая линия)** | Таблетки — по 1 под язык 2 раза в день 7 дней. Раствор — 6 мг в сутки парентерально 3 дня, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо под язык по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Свечи — 12 мг 1 раз в сутки, 10 свечей | C, 5 |
| **Тилорон (вторая линия)** | 125 мг в сутки первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток) | C, 5 |
| **Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)** | В 1-й день 8 таблеток: по 1 каждые 30 минут первые 2 часа, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления | C, 2 |
| **Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)** | Та же схема 1-го дня, затем по 1 таблетке 3 раза в день; всего 5 дней, с 18 лет | B, 2 |

Можно использовать интраназальные интерфероны: они действуют опосредованно и применяются в комплексной терапии с первых признаков болезни. В КР отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b — по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день, 3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки, 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный — по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день 5–7 дней.

Пациентам с неосложнённой ОРВИ, а также с частыми, тяжёлыми или затяжными респираторными инфекциями в анамнезе в комплексное лечение включают лизаты бактерий для стимуляции иммунитета. Их принимают с первых дней болезни по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды, пока не исчезнут симптомы, но не меньше 10 дней.

### 4.3 Жаропонижающие

При температуре выше 38 °C и болях в мышцах и суставах назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Препараты выбора — парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, не больше 4000 мг в сутки, и ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, не больше 1200 мг в сутки. Можно использовать комбинации ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяют только для снижения температуры и обезболивания, длительные курсы нецелесообразны. Они могут помешать врачу оценить, действует ли лечение.

### 4.4 Нос

Физиологический раствор натрия хлорида вводят в нос 2–3 раза в день: он разжижает секрет, удаляет слизь и восстанавливает работу мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяют местные деконгестанты, чтобы уменьшить заложенность носа и восстановить проходимость слуховой трубы.

| Препарат | Доза в каждый носовой ход |
|---|---|
| **Ксилометазолин** | 1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день |
| **Нафазолин** | 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки |

| Препарат | Доза в каждый носовой ход |
|---|---|
| **Ипратропия бромид + ксилометазолин** | Фиксированная комбинация при обильной ринорее; доза в КР не указана |
| **Оксиметазолин** | 0,05% раствор, 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки |

При назофарингите и неосложнённом риносинусите с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки с первого дня назначают комбинированный растительный препарат из корня горечавки, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины и травы вербены. Он улучшает работу мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление и помогает предупредить осложнения.

Сухой экстракт — 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день, измельчённое сырьё — 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день, капли — по 50 капель 3 раза в день; курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат можно назначить после консультации врача, в таблетках, а если их нельзя принимать — в каплях.

### 4.5 Горло

Для уменьшения воспаления и боли и профилактики вторичной инфекции слизистой ротоглотки назначают препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в полосканиях, инсуффляциях, ингаляциях, таблетках и пастилках для рассасывания.

Используют грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином), бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием, гексэтидин, лизоцим с пиридоксином, хлоргексидин, бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, биклотимол и препараты йода.

При фарингите и тонзиллите (боль в горле в покое и при глотании, гиперемия слизистой и миндалин, их увеличение) назначают растительный антисептик из корня алтея, цветков ромашки, травы тысячелистника, коры дуба, листьев грецкого ореха, травы хвоща и травы одуванчика. Он уменьшает боль и воспаление и помогает предупредить осложнения и новые эпизоды ОРВИ.

Таблетки — по 2 (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день, пока не пройдёт боль в горле, затем ещё неделю 3 раза в день. Препарат можно назначать беременным и пациентам с соматическими болезнями после консультации врача.

### 4.6 Кашель

При сухом непродуктивном надсадном кашле, который сильно ухудшает качество жизни (боль, нарушение сна), назначают противокашлевые средства: бутамират, леводропропизин, антитела к брадикинину, морфину и гистамину или декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в сиропе — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — 60 мг 1–3 раза в сутки с промежутками не меньше 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначают муколитики и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитики, в том числе растительные, применяют только при продуктивном кашле.

Ацетилцистеин — 600 мг в сутки до 5–7 дней; амброксол — 90 мг в сутки, в капсулах пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней. Растительные комбинации экстрактов тимьяна с плющом или первоцветом принимают 10–14 дней.

Отхаркивающие и противокашлевые средства одновременно не назначают: подавление кашлевого рефлекса может вызвать застой мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для отхождения вязкой мокроты проводят ингаляции через небулайзер гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме из-за бронхоспазма назначают комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в дозированном ингаляторе по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым можно назначить амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день 2 недели.

### 4.7 Антибиотики

Антибиотики не назначают при неосложнённой ОРВИ в первые 10–14 дней, в том числе при рините, конъюнктивите, затемнении пазух на рентгенограмме, ларингите, крупе, бронхите и бронхообструктивном синдроме.

Антибиотики назначают при вероятной сопутствующей бактериальной инфекции, если не помогают патогенетическое, симптоматическое и противовирусное лечение, и при бактериальных осложнениях среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ — бронхите, пневмонии и других.

### 4.8 Антибиотики при бактериальном риносинусите

| Препарат | Доза |
|---|---|
| **Амоксициллин** | 500–1000 мг 3 раза в сутки внутрь, 7–10 дней |
| **Амоксициллин и клавулановая кислота** | 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки внутрь, 7–10 дней |
| **Азитромицин** | 500 мг 1 раз в сутки внутрь, 3 дня |
| **Кларитромицин** | 500 мг 1 раз в сутки, 7–10 дней (кратность — как в КР) |
| **Левофлоксацин** | 500 мг внутрь до 5–7 дней — при устойчивой флоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики |

> В КР есть расхождение в сроках. Антибиотики не рекомендуют до 10–14 дней даже при затемнении пазух на рентгенограмме. Но рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит советуют делать уже после 3–5 дней заложенности, а в разделе об организации помощи сохранение высокой температуры больше 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Пневмонию в этих рекомендациях не рассматривают: её лечат по клиническим рекомендациям по внебольничной пневмонии у взрослых.

### 4.9 Тяжёлое течение

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком мозга назначают системные глюкокортикоиды; такого пациента лечат в ОРИТ по рекомендациям для неотложных состояний.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 ниже 92%) дают кислород через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начинают с потока 5–7 л/мин, при необходимости увеличивают до 10 л/мин, чтобы SpO2 была выше 90%.

### 4.10 Другие препараты

Для защиты слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарств, в том числе НПВП, назначают омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики назначают пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, кожными болезнями, а также при приёме антибиотиков дольше 7 дней сейчас или в предыдущие 1–2 месяца. Их дают в ранние сроки болезни вместе с другими препаратами.

### 4.11 Реабилитация

Реабилитацию начинают в период ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении назначают общетонизирующие препараты — оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, следующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановление проводят комплексно, с участием разных специалистов, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и постоянным контролем результата. Физическую и умственную нагрузку увеличивают постепенно.

---

## 5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

### 5.1 Госпитализация

Прежде чем выбрать тактику, определяют, неосложнённое или осложнённое течение у пациента.

Лёгкую и среднетяжёлую ОРВИ лечат амбулаторно. Если лечение не помогает или его нельзя провести дома, решают вопрос о госпитализации.

Госпитализируют пациентов с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением, из групп риска, а также по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением, если пациент живёт в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В КР противоречие о среднетяжёлом течении: одна рекомендация раздела 6 предписывает лечить таких пациентов амбулаторно, следующая — госпитализировать.

Срочно госпитализируют при частоте дыхания больше 24 в минуту, SpO2 ниже 95% и очаговых изменениях на рентгенограмме грудной клетки.

В ОРИТ переводят при быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания больше 30 в минуту, SpO2 ниже 90%, систолическое давление ниже 90 мм рт. ст.) и другой органной недостаточности, например острой почечной.

> Пороги для ОРИТ в КР разные: в разделе 2.5 анестезиолога-реаниматолога зовут при частоте дыхания больше 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 переводят в ОРИТ при частоте дыхания больше 30 и SpO2 ниже 90%.

Схему ведения срочно пересматривают, если болезнь прогрессирует. Это признаки нехватки кислорода и сердечно-лёгочной недостаточности (одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в груди, гипотония, низкая сатурация), поражения нервной системы (нарушение сознания, сонливость, судороги, сильная слабость, параличи), вторичной бактериальной инфекции (в том числе высокая температура и другие симптомы дольше 3 дней) и тяжёлого обезвоживания.

Выписывают при стойком улучшении, нормальной температуре, после стихания респираторно-катарального синдрома и при нормальном общем анализе крови.

К группам риска тяжёлого течения относятся беременные и родильницы, пациенты с хроническими болезнями лёгких, сердца и сосудов, сахарным диабетом и ожирением 2–3 степени, хронической болезнью почек, болезнями печени, некоторыми неврологическими состояниями, гемоглобинопатиями, иммунодефицитами, злокачественными опухолями, а также люди 65 лет и старше.

### 5.2 Наблюдение после болезни

При осложнениях пациента наблюдает терапевт, после аденовирусной инфекции — инфекционист в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.

Месяц после выписки прививки не делают, кроме анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После болезни ограничивают пребывание на солнце на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести.

### 5.3 Профилактика

Вакцин против ОРВИ нет.

Среди контактных выявляют заболевших. Больного изолируют дома, при необходимости — в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем на 1–2 недели; после этого он может вернуться к работе. Карантин для контактных не вводят.

При работе с больными ОРВИ носят маску и меняют её каждые 3–4 часа.

Обеззараживают посуду, воздух и поверхности, проводят влажную уборку и проветривают помещения.

После контакта с больным ОРВИ проводят химиопрофилактику. Экстренную профилактику в очаге продолжают 2 дня, если контакт прекратился, и 5–7 дней, если он сохраняется. Плановую сезонную профилактику проводят перед эпидемией людям с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

| Препарат | Доза для профилактики | УУР, УДД |
|---|---|---|
| **Умифеновир** | После контакта — 200 мг в сутки 10–14 дней; сезонно — 200 мг 2 раза в неделю 3 недели | B, 3 |
| **Оксодигидроакридинилацетат натрия** | 250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток | C, 4 |
| **Интерферон альфа-2b** | По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки 5–7 дней; при однократном контакте достаточно одного закапывания | B, 3 |
| **Интерферон гамма человеческий рекомбинантный** | По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака 10 дней | B, 3 |
| **Меглюмина акридонацетат** | После контакта не позже 3 дней назад — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки | C, 5 |
| **Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат** | 200 мг в сутки после еды 14 дней | C, 5 |
| **Азоксимера бромид** | 1 таблетка в день 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или под язык, или свечи 12 мг 1 раз в сутки, 10 свечей | C, 5 |
| **Тилорон** | 125 мг 1 раз в неделю 6 недель | C, 5 |
| **Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)** | 1 таблетка в день 1–3 месяца в период подъёма заболеваемости | B, 2 |

Лизаты бактерий назначают для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции независимо от сезона людям, живущим в неблагоприятных экологических условиях, и пациентам с хроническими болезнями дыхательных путей и глотки — хроническим бронхитом, ХОБЛ, бронхиальной астмой, хроническим риносинуситом, хроническим тонзиллитом. Их принимают тремя курсами по 10 дней с перерывами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, назначают #колекальциферол: без ожирения — 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю, при ожирении — 3000–6000 МЕ в сутки (знак # означает применение вне инструкции).

Пациенту объясняют, что нужно срочно обратиться к врачу при высокой температуре, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте без облегчения и резком падении давления.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых» |
| Версия | 2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года |
| Код в рубрикаторе | 724_2 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчики | Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского |
| Пациенты | Взрослые |

### 6.1 Неточности в самом тексте КР

- Среднетяжёлую ОРВИ раздел 6 в одной рекомендации предписывает лечить амбулаторно, а в следующей — госпитализировать.
- Пороги для реанимации расходятся: в разделе 2.5 — частота дыхания больше 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 — больше 30 в минуту и ниже 90%.
- Антибиотики не рекомендуют до 10–14 дней даже при затемнении пазух, но рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит советуют уже после 3–5 дней заложенности, а температуру дольше 3 дней раздел 6 считает признаком вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография пазух стоит только на ветке с изменениями в лёгких без пневмонии, а в разделе 2.4 её назначают по длительности затруднения носового дыхания.
- КР написаны для взрослых, но рекомендация против антибиотиков говорит о «взрослой и детской практике».
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; у оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; у бромгексина доза записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).
- В разделе 2.2 уровень доказательств записан как «уровень доказательности» и «уровень доказательства»; у рекомендации о пульсоксиметрии уровни стоят после комментария.
- Критерии качества требуют коагулограмму, маркёры воспаления и антибиотики при «остром бактериальном тонзиллите», хотя в тексте рекомендаций этого нет.
- В таблице приложения А3.4 у парагриппа в строке ведущего синдрома стоит оборванная фраза «выявляют крайне».